

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ALEXITIMIA DE TORONTO (TAS-20)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Conciencia Afectiva, Mentalización y Alexitimia Clínica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Alexitimia de Toronto de 20 Ítems (TAS-20).
Nombre Original (Inglés)	<i>Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20)</i>
Autores Originales	Drs. R. Michael Bagby, James D. A. Parker y Graeme J. Taylor (1994), University of Toronto.
Adaptaciones Españolas	Martínez-Sánchez (1996); Moral de la Rubia (2008); Páez et al. (1999).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Constructo de Alexitimia (Sifneos / Nemiah).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 20 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde los 15 años). Esencial en medicina psicosomática, adicciones y trauma.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en autoadministración; 6 minutos asistido.
Régimen y Propiedad	Instrumento propietario con copyright (MHS / Graeme J. Taylor). Esta ficha técnica documenta su psicometría clínica y orienta su adquisición mediante distribuidores oficiales autorizados.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA ALEXITIMIA

La TAS-20 constituye el patrón oro psicométrico a nivel internacional para evaluar el constructo de **alexitimia**, introducido originalmente por Peter Sifneos y John Nemiah. Se define como un déficit específico en el procesamiento cognitivo y la regulación verbal de los afectos, caracterizado por la dificultad para identificar y describir sentimientos, la incapacidad de distinguir entre sensaciones corporales y estados emocionales, y un estilo de pensamiento pragmático y desprovisto de introspección (**pensée opératoire**).

En el plano neurobiológico, la alexitimia se asocia a un fallo en la transferencia interhemisférica ("comisurotomía funcional") y a una marcada hipoactivación de la corteza cingulada anterior rostral (rACC) y del córtex prefrontal ventromedial. Al no poder simbolizar conscientemente el afecto displacentero en palabras, la activación límbico-amigdalina se deriva directamente al sistema nervioso autónomo y al eje neuroendocrino, transformando las emociones no procesadas en somatizaciones viscerales masivas (colon irritable, dolor crónico, fibromialgia) o conductas adictivas de anestesia somática.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor TAS-20	Ítems (20)	Inversos	Definición Operativa y Fenomenológica
1. Dificultad para Identificar (DIF)	1, 3, 6, 7, 9, 13, 14 (7)	Ninguno	Incapacidad para reconocer qué emoción se siente y confusión constante entre emociones y sensaciones somáticas.
2. Dificultad para Describir (DDF)	2, 4, 11, 12, 17 (5)	Ítem 4	Carencia de vocabulario afectivo y dificultad manifiesta para comunicar las emociones propias a otras personas.
3. Pensamiento Externo (EOT)	5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20 (8)	5, 10, 18, 19	Focalización estricta en detalles fácticos cotidianos, rechazo del análisis introspectivo y ausencia de fantasía.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en España: alfa de Cronbach de 0.81 a 0.86 para la escala total (Martínez-Sánchez, 1996; Moral de la Rubia, 2008); subescalas: DIF (0.80 a 0.83), DDF (0.75 a 0.78) y EOT (0.66 a 0.70).
Estructura Trifactorial	El AFC confirma el modelo trifactorial intercorrelacionado (CFI = 0.94, RMSEA = 0.052), replicando de manera exacta la arquitectura factorial demostrada por Bagby y Taylor en muestras anglosajonas.
Estabilidad Temporal	Elevada consistencia test-retest ($r = 0.77$ a los 6 meses), confirmando su cualidad de rasgo disposicional de personalidad estable frente a estados transitorios.
Validez Concurrente y Clínica	Correlaciones muy elevadas con somatización somática (PHQ-15, $r = 0.54$), hipocondría, dependencia a sustancias y dolor crónico; y correlaciones inversas con inteligencia emocional (TMMS-24, $r = -0.62$) y empatía.
Sensibilidad al Cambio	Sensible a intervenciones de Terapia Basada en la Mentalización (MBT) y psicoterapia expresiva orientada al cuerpo, reflejando descensos clínicamente significativos en DIF y DDF tras el tratamiento.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica de 1 a 5 (1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 4 = «De acuerdo», 5 = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Inversión de Ítems Positivos):** Los reactivos **4, 5, 10, 18 y 19** deben invertirse obligatoriamente: 1 → 5, 2 → 4, 3 → 3, 4 → 2, 5 → 1.
- **Paso 2 (Factores Específicos):** DIF = suma ítems 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14 (rango 7 a 35); DDF = suma ítems 2, 4(inv), 11, 12, 17 (rango 5 a 25); EOT = suma ítems 5(inv), 8, 10(inv), 15, 16, 18(inv), 19(inv), 20 (rango 8 a 40).
- **Paso 3 (Puntuación Total TAS-20):** Suma de los 20 ítems tras la inversión. Rango total: **20 a 100 puntos**.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE CLÁSICOS (Bagby & Taylor, 1994)

Estratificación	Puntuación Total	Estado Afectivo	Pronóstico y Recomendación Terapéutica
No Alexitimia	20 a 51 puntos	Procesamiento emocional normativo	Capacidad adecuada para identificar, verbalizar y modular sentimientos. Buena receptividad a psicoterapia verbal estándar.
Posible / Zona Límite	52 a 60 puntos	Dificultades afectivas moderadas	Restricción parcial de la expresión emocional ante estrés severo. Psicoeducación en mentalización y vocabulario afectivo.
Alexitimia Clínica	61 a 100 puntos	Alexitimia significativa (corte >= 61)	Déficit severo de mentalización. Alto riesgo psicosomático y fracaso terapéutico si solo se usan técnicas introspectivas clásicas.

VALOR PRONÓSTICO DEL CORTE >= 61 EN PSIQUIATRÍA Y MEDICINA:

El punto de corte **>= 61 puntos** define la alexitimia clínicamente relevante. Estos pacientes presentan una tasa tres veces superior de hiperfrecuentación a servicios de urgencias por molestias físicas no explicadas médicamente y suelen abandonar prematuramente la psicoterapia dinámica o cognitiva convencional si no se adapta el ritmo a su estilo cognitivo concreto.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES ALEXITÍMICOS

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN EL PERFIL TAS-20:

- **Regla de Oro Inicial:** Jamás formular preguntas abiertas complejas como “¿Cómo te sientes?”. El paciente sentirá frustración o inventará respuestas vacías.
- **Paso 1: Alfabetización Afectiva Asistida:** Usar la rueda de las emociones y termómetros visuales para ofrecer un menú cerrado de etiquetas afectivas básicas (alegría, enfado, tristeza, miedo, asco).
- **Paso 2: Enlace Somatopsíquico:** Conectar sensaciones corporales concretas con eventos relacionales (ej. “el nudo en el estómago apareció justo cuando tu jefe te criticó; eso suele llamarse tensión o rabia”).
- **Paso 3: Terapia Basada en la Mentalización (MBT):** Desarrollar la capacidad de atribuir estados mentales a la conducta observable.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DOLOR CRÓNICO Y SOMATIZACIÓN

Paciente: Varón de 45 años, jefe de almacén, remitido por la unidad del dolor con diagnóstico de lumbalgia crónica inespecífica y cefaleas tensionales rebeldes. Durante la entrevista clínica, el paciente se muestra plano, hiperconcreto en su relato laboral e incapaz de asociar su dolor al fallecimiento reciente de su hermano.

Evaluación Cuantitativa Inicial TAS-20: Total = **74 puntos** (Alexitimia severa; percentil 94 clínico).

• **Subescalas:** Dificultad para Identificar (DIF) = **29 / 35 puntos**; Dificultad para Describir (DDF) = **21 / 25 puntos**; Pensamiento Externo (EOT) = **24 / 40 puntos**.

Formulación Clínica: Trastorno de Somatización mantenido por alexitimia severa. La falta de procesamiento mental del duelo se manifiesta a través de un canal exclusivo de descarga autonómica muscular y visceral.

Tratamiento y Evolución: Se implementó psicoterapia de alfabetización afectiva y biofeedback somatosensorial de 16 sesiones. El paciente aprendió a reconocer la opresión torácica como tristeza y a permitirse llorar. A los 5 meses: TAS-20 Total descendió a **53 puntos** (DIF bajó a 18), disminuyendo el dolor en un 60% y prescindiendo de opiáceos menores.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE LA PROPIEDAD LEGAL

LICENCIA COMERCIAL Y ADQUISICIÓN OFICIAL

El instrumento TAS-20 está sujeto a copyright de los autores y de Multi-Health Systems (MHS Inc.). La reproducción comercial del protocolo físico requiere de la licencia oficial del titular; esta ficha técnica tiene fines exclusivamente formativos y docentes.

ALEXITIMIA PRIMARIA VS. SECUNDARIA

Diferenciar entre alexitimia como rasgo biológico del neurodesarrollo (primaria) y la alexitimia secundaria inducida por trauma complejo (mecanismo defensivo de desensibilización para sobrevivir a situaciones de estrés extremo).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure. *Journal of Psychosomatic Research*, 38(1), 23–32.
2. Martínez-Sánchez, F. (1996). Adaptación española de la Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20). *Clínica y Salud*, 7(1), 19–32.
3. Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. (1999). *Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness*. Cambridge University Press.
4. Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of alexithymic characteristics in psychosomatic patients. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 22(2-6), 255–262.